

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	缺血性心臟病 Ischemic Heart Disease ; IHD				
編號	A31000-Q03-W-B21	制定者	N13 翁岱鈺	公布日期	112 年 02 月 07 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	112 年 02 月 07 日
版本/總頁數	第 1.0 版/6 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 08 月 07 日

一、目的

讓護理人員了解缺血性心臟病的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

缺血性心臟病，又稱為冠狀動脈心臟病，是當冠狀動脈狹窄或閉塞，無法有效供應心肌養分及氧氣，致使心肌缺氧、損傷，甚至壞死，造成無法彌補的傷害。

（二）症狀

缺血性心臟病可分為兩種主要的類型，心絞痛及心肌梗塞。心絞痛是心肌暫時性缺氧引起的臨床症狀，其主要特徵為「用力→疼痛→休息→緩解」；心肌梗塞約有 80% 以上的病人因為心肌缺氧，而有不同程度的胸痛，主要在左胸或胸骨下或心前區、劍突處大範圍的疼痛，症狀為在休息或活動時出現的胸部疼痛或不適，疼痛時間可以持續 15 分鐘以上，無法藉由舌下含服硝酸甘油酯(NTG)或休息來緩解。

（三）常見檢查

1. 十二導程心電圖檢查(Electrocardiogram, ECG)。
2. 24 小時霍特氏心電圖(Holter's EKG)。
3. 心導管檢查(Cardiac cath exam)。
4. 心肌血流灌注掃描(Myocardial Perfusion scan)。

主題名稱	缺血性心臟病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B21	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	2/6

5. 心臟超音波(Cardiac echo)。
6. 多切面電腦斷層冠狀動脈攝影。
7. 心肌酶 (肌酸磷酸激酶<CPK、CPK-MB>、乳酸脫氫酶<lactic dehydrogenase>、
心肌旋轉蛋白<cardiac troponin>)。
8. 運動心電圖。
9. 血脂濃度的測定。

(四) 常見治療

1. 藥物治療：藥物治療目的為降低心肌需氧量，及增加冠狀動脈血流量，以緩解心肌缺氧情況。包含：硝酸甘油酯、β 型阻斷劑、鈣離子阻斷劑、血小板抑制劑、Statin 類藥物。
2. 經皮冠狀動脈介入治療術(PCI)。
3. 冠狀動脈支架置入術。
4. 冠狀動脈粥狀硬化物刮除術(Coronary Atherectomy)。
5. 冠狀動脈繞道手術(Coronary Artery Bypass Graft, CABG)。

(五) 護理問題

1. 疼痛不適/與冠狀動脈血流減少有關。
2. 心肺血流不足/與心臟血管疾病導致心輸出量及組織灌流量減少有關。
3. 活動耐力不足/與心肌受損導致心輸出量不足有關。
4. 易受傷害/與使用血小板抑制劑、抗凝血藥物有關。

(六) 護理措施

1. 疼痛不適/冠狀動脈血流減少有關：
 - (1)監測生命徵象，觀察心肌缺氧的表徵。
 - (2)視需要抬高床頭，使胸部擴張及減少回心血量。
 - (3)評估病人的疼痛的特性、部位、嚴重度與其他合併症的症狀等。
 - (4)評估疼痛加劇的原因。
 - (5)若病人焦慮、害怕，可依醫囑輔以鎮靜劑，促進休息與睡眠。

主題名稱	缺血性心臟病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B21	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	3/6

(6)依醫囑給予止痛劑。

(7)必要時依醫囑使用氧氣。

2. 心肺血流不足/與心臟血管疾病導致心輸出量及組織灌流量減少有關：

(1)密切監測心電圖的變化，早期發現致命性心律不整。

(2)監測記錄生命徵象，尤其是血壓變化，並報告醫師。

(3)密切監測呼吸型態及呼吸音的變化，必要時依醫囑使用氧氣，以增加心肌之供氧。

(4)監測周邊循環，觸診末梢肢端是否溫暖或冰冷，或出現發紺、盜汗等現象。

(5)監測輸入量及輸出量，即早發現有無少尿或水腫情形，維持每小時尿量在 30c.c.以上。

(6)監測每日體重並記錄。

(7)注意各項實驗室檢驗報告之數據，如：心肌酶的變化，並通知醫師。

(8)視需要協助病人抬高床頭採半坐臥姿勢，使胸部擴張及減少回心血量。

(9)注意能活動病人的安全，防意外發生，避免姿勢性低血壓引起暈眩而跌倒。

(10)教導適度運動及休息，以增加身體對活動的耐受力。

(11)依醫囑採低鈉、低熱量、低脂肪、低膽固醇與高纖維之飲食，採少量多餐，以減少心臟負荷。

(12)依醫囑給予軟便劑，預防便秘；依醫囑給予止痛劑、抗凝血劑、血栓溶解劑，並監測藥物反應及效果。

3. 活動耐力不足/與心肌受損導致心輸出量不足有關：

(1)建立漸進性運動計畫，以增加活動耐受力。

(2)協助病人認識活動耐受力的相關知識：教導病人與家屬自我監測脈搏與計算最大心率的方法；教導病人辨識活動無耐力指標，如：活動後休息 5 分鐘，心跳仍大於休息時 20 次，活動過程中即感到暈眩、呼吸短促、虛脫感等不適，皮膚溼冷，步態不穩皆為耐力不夠的表徵；養成規律運動習慣，漸進地達成心肺訓練。

主題名稱	缺血性心臟病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B21	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	4/6

- (3)依醫囑服用藥物可促進活動的耐力。
- (4)教導學習或練習鬆弛技巧以避免促使活動無耐力。
- (5)教導當引起疼痛或疲累時，便終止或減少活動。
- (6)教導監測自己對活動的生理反應，有助於評估日常生活活動度。
- (7)判斷病人或配偶是否有性諮商的需要，適時給予資訊。

4. 易受傷害/與使用血小板抑制劑、抗凝血藥物有關：

- (1)解釋易出血與使用血小板抑制劑、抗凝血藥物有關，教導病人耐心接受治療
並注意減少出血危險性的事項：
 - A.避免挖鼻孔和擤鼻涕。
 - B.使用軟毛牙刷，避免傷害牙齦。
 - C.避免任何引起創傷的情況，如：劇烈活動、與粗糙面的摩擦。
 - D.執行侵入性治療，如：抽血時，應延長壓迫止血時間，至完全止血。
- (2)監測生命徵象、意識狀態之變化及出血表徵。
- (3)監測生化檢驗值及凝血功能，包括 Hb，APTT，PT 等。
- (4)評估去除環境的危險因子：
 - A.當病人臥床時，隨時圍上床欄，固定床輪。
 - B.穿不會滑的拖鞋，並鼓勵至少一位家屬隨時陪伴病人。
 - C.教導使用輪椅及輔具。
 - D.教導家屬及病人如何使用呼叫鈴。
- (5)指導有關出血的預防和症狀評估。
- (6)告知病人及家屬對於早期出血的處理方法。
 - A.平躺休息，不要亂動。
 - B.壓迫出血處。
 - C.儘快通知醫護人員處理。

主題名稱	缺血性心臟病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B21	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	5/6

(七) 衛教指導

1. 給予「心絞痛的簡介」之衛教單張。
2. 給予「心肌梗塞之介紹」之衛教單張。
3. 給予「心臟病人的運動復建計畫」衛教單張。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 方妙君、杜玲(2021)·內外科護理學·於胡月娟總校閱，心臟血管系統疾病病人之護理
(六版，464-484 頁)·華杏。
- (二) 衛生福利部 (2022 年 8 月 29 日)·認識冠心病，<https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=632&pid=1188>
- (三) National Heart, Lung, and Blood Institute(2022). Coronary Heart Disease.
<https://www.nhlbi.nih.gov/health/coronary-heart-disease>

七、附件

(略)

